Wat bepaalt onze gezondheid

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Determinanten

Vier soorten determinanten, en de toets is wie of wat eraan kan sleutelen. Persoonlijk zit in de persoon en is meestal onveranderlijk, leefstijl is gedrag, omgeving is alles errond, en het zorgstelsel gaat over de beschikbaarheid van zorg.

1 Welke determinant?

a) persoonlijk · b) leefstijl · c) omgeving · d) zorgstelsel · e) persoonlijk · f) omgeving

Werkloosheid in het gezin staat bij omgeving en niet bij persoonlijk. Dat is belangrijk: het is geen eigenschap van het kind, en toch beïnvloedt het zijn gezondheid sterker dan de meeste eigen keuzes.

2 Welke determinanten kan iemand zelf veranderen, en welke niet?

De leefstijl is gedeeltelijk een eigen keuze. Leeftijd, geslacht en erfelijkheid niet, en de omgeving en het zorgstelsel maar beperkt. Daarom is enkel naar de leefstijl kijken onrechtvaardig.

Let op de laatste zin van het antwoord, want daar zit de kern van het hoofdstuk. Wie enkel naar de leefstijl kijkt, legt de hele verantwoordelijkheid bij de persoon terwijl drie van de vier determinanten buiten hem liggen.

2 De gezondheidskloof

De gezondheidskloof is geen kloof tussen arm en rijk maar een trap: bij elke stap hoger in opleiding of inkomen leeft men gemiddeld langer. Antwoord bij deze reeks dus altijd met meer dan de eigen keuze: met prijs, afstand, tijd en omgeving.

3 Wat bedoelt men met de sociale gradiënt in gezondheid?

Hoe lager iemands inkomen en opleiding, hoe slechter gemiddeld zijn gezondheid en hoe korter zijn leven. Het is geen kloof tussen twee groepen maar een trap die over alle lagen loopt.

Het woord gradiënt is hier het juiste woord: het gaat niet om twee groepen maar om een geleidelijk verloop. Ook wie het goed heeft, leeft gemiddeld korter dan wie het nóg beter heeft.

4 Waarom is gezonder eten voor een gezin met weinig geld niet enkel een kwestie van willen?

Verse producten zijn duurder per calorie, een winkel met keuze is niet altijd dichtbij, en wie twee jobs combineert heeft geen tijd om te koken.

Noem alle drie de redenen, want ze zijn van een andere soort: geld, afstand en tijd. Dat derde wordt het vaakst vergeten en weegt zwaar bij wie onregelmatige uren werkt.

5 Noem twee maatregelen van de overheid die de gezondheidskloof kleiner maken.

Gratis of goedkope preventieve zorg, de gezondheidscheque en de maximumfactuur, gezonde maaltijden op school, rookverboden, veilige fietspaden in elke wijk.

Twee volstaan. Twee Belgische maatregelen die je bij naam kan noemen, zijn de maximumfactuur, die begrenst wat een gezin per jaar aan zorg betaalt, en de regeling derdebetaler, waarbij je bij de huisarts enkel het eigen deel betaalt.

3 Gezondheidsbevordering

Houd twee soorten aanpak uit elkaar: een campagne of voorlichting spreekt de persoon aan, een structurele maatregel verandert de omgeving. Het tweede werkt beter, omdat het de gezonde keuze de gemakkelijkste maakt in plaats van de moeilijkste.

6 Vul aan.

a) een campagne · b) structurele maatregelen · c) een structurele maatregel · d) voorlichting · e) de omgeving inrichten · f) participatie

7 Waarom werkt een affiche over gezond eten in een school zonder gezond aanbod niet?

Je vraagt iets wat ter plaatse niet kan. Zonder een aanbod dat de keuze mogelijk maakt, legt een campagne de last volledig bij de leerling.

Dit is het hele hoofdstuk in één voorbeeld. Een affiche zonder aanbod vraagt iets wat ter plaatse niet kan, en de leerling die het niet doet, krijgt dan nog het verwijt erbovenop.